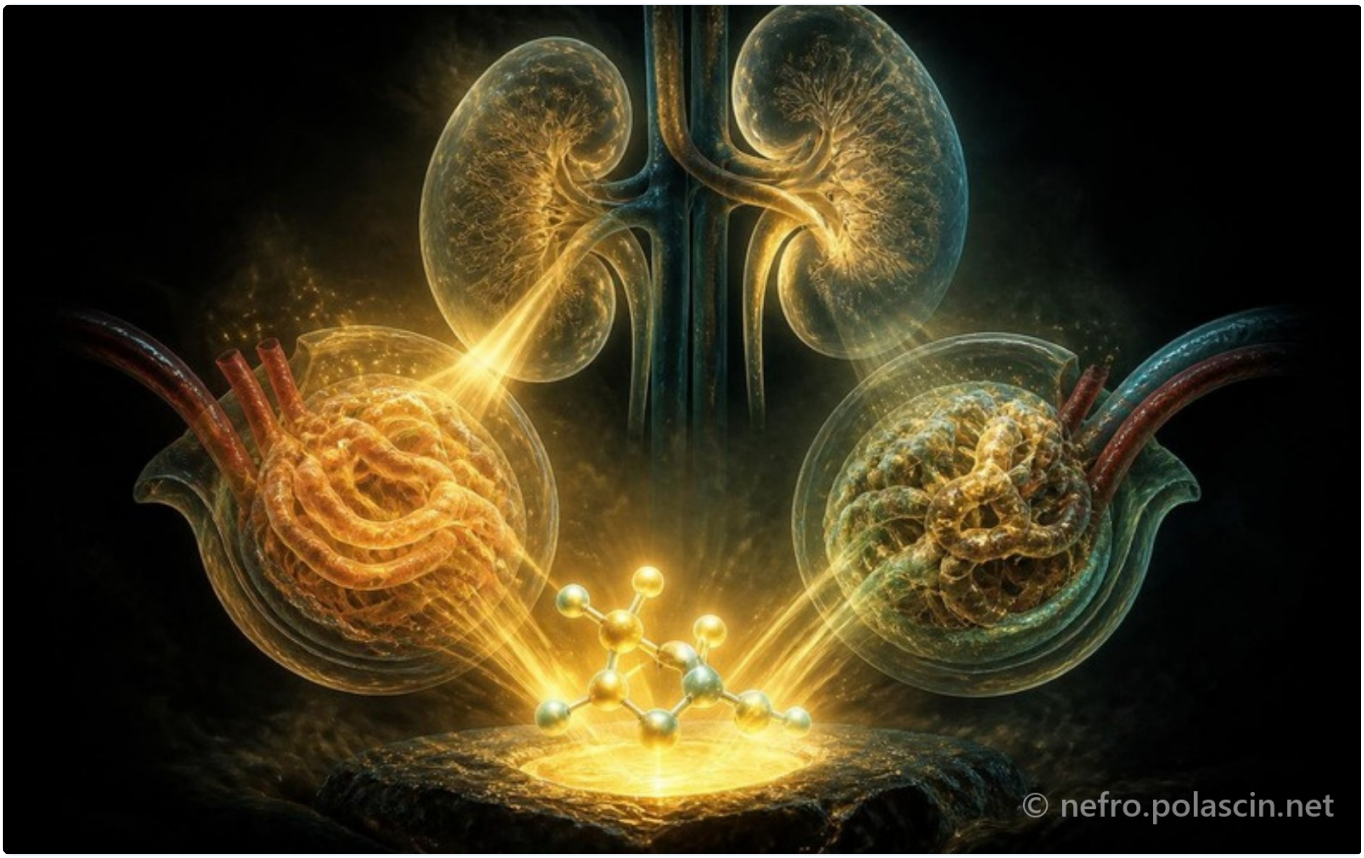
Finerenón: potenciál ako základná liečba pri CKD aj bez diabetu a pri glomerulových ochoreniach

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Poloschematická vizualizácia. Ak účinok nezávisí od diabetu, posúva sa liek z doplnku smerom k základnej liečbe.

Portál ScienceDaily zhrnul výsledky viacerých veľkých štúdií, v ktorých **finerenón** spomaľoval zhoršovanie funkcie obličiek a znižoval aj kardiovaskulárne riziko. Prínosy sa pozorovali nielen u pacientov s diabetom, ale aj pri **nediabetickom CKD** a v skupinách s **glomerulovými ochoreniami**.

Kľúčové štúdie a výsledky

1) FIND-CKD: nediabetické CKD

V štúdii **FIND-CKD** (1 584 účastníkov, 24 krajín) finerenón pridaný k štandardnej liečbe:

- **spomalil pokles funkcie obličiek**,
- znížil kombinovaný cieľ (**zlyhanie obličiek, progresia CKD, srdcové zlyhanie alebo kardiovaskulárne úmrtie**) o **23 %** oproti štandardnej starostlivosti.

2) Analýza pre glomerulové ochorenia (JAMA)

U účastníkov s glomerulovými ochoreniami finerenón:

- znížil riziko **zlyhania obličiek alebo progresie CKD** o **26 %** oproti placebu,
- po **12 mesiacoch** znížil **albuminúriu o 42 %**.

3) Súhrnná analýza naprieč diabetickým aj nediabetickým CKD (The Lancet)

Súhrnná (pooled) analýza zahrnula **14 574 účastníkov** a finerenón v nej:

- znížil riziko **zlyhania obličiek alebo progresie CKD** o **24 %**,
- znížil riziko **hospitalizácie pre srdcové zlyhanie alebo kardiovaskulárneho úmrtia** o **20 %**,

- znížil riziko **úmrtia z akejkoľvek príčiny** o **12 %**.

Autori uvádzajú, že tieto prínosy boli konzistentné bez ohľadu na prítomnosť diabetu, typ ochorenia obličiek a mieru zníženia funkcie.

Bezpečnosť (draslík)

Finerenón bol vo všeobecnosti **dobre tolerovaný**, no **hyperkaliémia** sa vyskytovala častejšie než pri placebe. Ukončenie liečby pre hyperkaliémiu a hospitalizácie z tohto dôvodu však boli podľa zdroja **nečasté**.

Aj pri širšej indikácii preto treba draslík a renálne parametre sledovať disciplinovane.

Praktické ponaučenie

Podľa týchto výsledkov by finerenón mohol mať pevnejšie miesto v liečbe CKD aj u pacientov, ktorí:

- **nemajú diabetes**,
- patria ku **glomerulovým** fenotypom,
- a zároveň majú **klinicky významný renálny rizikový profil**, pri ktorom možno očakávať prínos aj na albuminúrii a klinických cieľových ukazovateľoch.

Treba však zostať zdržanliví: výsledky pochádzajú z populárno-vedeckého súhrnu, nie z úplných protokolov so štatistickými detailmi. Možno ich chápať ako výsledky viacerých štúdií s konzistentným smerom; pri nasadzovaní u konkrétnych pacientov je rozumné riadiť sa lokálnymi odporúčaniami a schémou monitorovania draslíka.

Zdroj: *ScienceDaily (6. jún 2026): „Finerenone May Benefit Far More Patients...“. Link na zdroj.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=finerenon-zakladna-liecba-ckd-glomerularne-ochorenia · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.